

D O C U M E N T O E S T R A T É G I C O · C O N F I D E N C I A L

B C M · L A V I T A C O D E

A janela mais curta do mercado clínico digital brasileiro.

R\$ 75.000 · **5% do BCM** · 3 tranches com gatilhos reais

A p r e s e n t a d o a

Grupo Gradual

Dra. Leila Bagaíolo · Dra. Claudia Romano Pacifico

V A L I D A D E

15 dias

até 22 de maio de 2026

O Grupo Gradual não está sendo convidado a *investir em uma startup*.

Está sendo convidado a **comprar a primeira posição** na fundação do padrão clínico digital ABA do Brasil — com **retorno operacional já no mês 1**.

5% do BCM

equity em ativo funcional, já em produção

25% off em software

economia recorrente que paga o cheque

Posição estratégica

antes da rodada, antes do padrão se fixar

Tudo o que importa, em um cartão.

Seis razões pelas quais a decisão se sustenta sozinha — antes mesmo da apresentação completa.

O A T I V O

Plataforma pronta

Avaliação, PEI, CAA, jogos, telemetria, Visão 360.
Em produção, não em slides.

O C H E Q U E

R\$ 75.000 em 3 etapas

Apenas R\$30K na assinatura. R\$25K e R\$20K só com prova de mercado.

O E S C U D O

Risco assimétrico

Tranche 2 e 3 dependem de usuários pagantes ativos. Sem prova, sem cheque.

O R E T O R N O

Já se paga em 2-3 anos

25% off em software + 30% off no Plano Clínica.
Retorno antes do BCM escalar.

A P O S I Ç Ã O

Investidor-âncora

Coautoria científica, voto técnico-clínico e acesso à narrativa de mercado.

A J A N E L A

15 dias

A primeira parceria clínica define autoria, dados e narrativa do setor.

P O R Q U E A G O R A

A pressão regulatória já chegou. O mercado ainda não tem um padrão.

918K

crianças com TEA no Brasil

base INEP

+44%

crescimento de diagnósticos

em 1 ano

94,2%

professores sem formação ABA

déficit estrutural

R\$ 320K

custo médio de litígio

por não conformidade

O G A T I L H O

- PEI obrigatório nas escolas.
- Planos exigem documentação clínica defensável.
- Clínicas precisam provar evolução, não apenas registrar sessão.

O C U S T O D E E S P E R A R

- Outro grupo clínico ocupa a posição estratégica.
- Outro protocolo vira o primeiro nativo do marketplace.
- A janela de entrada vira janela de cliente comum.

O Q U E É O B C M

Não é prontuário. Não é app de jogos.

É um sistema clínico onde cada módulo alimenta o próximo.

01

Avaliação clínica

3 protocolos default +
protocolos do parceiro



02

Kernel de decisão

Processa dados, deriva
metas, aciona módulos



03

PEI automático

35 min • baselines • SMART •
PDF defensável



04

Intervenção ativa

Jogos • rotinas • CAA • FCT •
VB-MAPP



05

Evidência contínua

Telemetria • ANS • escola •
família

1

ambiente único

*avaliação, intervenção e
monitoramento*

0

retrabalho clínico

*o dado nasce estruturado e
segue o fluxo*

360°

visão integrada

*criança, terapeuta, família e
escola*

BCM transforma avaliação clínica em plano mensurável — e intervenção em evidência.

PRODUTO FUNCIONANDO HOJE

12 módulos. Em produção. Auditáveis.

Não estamos pedindo capital para construir uma ideia. Estamos pedindo capital para escalar um ativo.

01

PSRF-BCM

21 probes • 7 domínios • output direto

02

PSFA-BCM

4 condições • hipótese funcional

03

EPS-PCA

24 trials • 5 canais • adaptação UX

04

Kernel Clínico

motor genérico • metas • governança

05

PEI Digital

35 min • baselines • mastery • PDF

06

Minha Voz

PECS • voz PT-BR • FCT • clínico

07

Rotinas

fichas • fading • vinculadas ao PEI

08

32 Jogos

5 mundos • telemetria completa

09

Visão 360

PSRF • PSFA • EPS • PEI • comportamento

10

Relatórios

ANS • escolar • progresso • período

11

Acesso progressivo

criança • responsável • terapeuta • admin

12

Stack SaaS

Angular • NestJS • AWS • LGPD • Claude

R\$150K investidos pelo fundador • **3 anos** de construção contínua • **AWS** Activate aprovado

O verdadeiro ativo não é o PEI. É o kernel que aceita qualquer protocolo.

INPUTS CONFIGURÁVEIS

Protocolo do caso

Defaults BCM:

PSRF · PSFA · EPS-PCA

Lista preferencial:

OERA · VB-MAPP · ABLLS-R · PEP-3 · CARS-2 · Vineland-3 · SRS-2

Regra: 1 protocolo ou combinação no mesmo caso clínico.

KERNEL BCM

O motor clínico

- Mapeia domínios e escalas
- Processa dados de avaliação
- Deriva metas clínicas
- Aciona jogos, rotinas, CAA, FCT
- Gera evidência contínua

OUTPUTS

Plano clínico digital

- PEI automático
- Metas SMART
- Baselines auditáveis
- Critérios de mastery
- Relatórios escola, ANS, família

Para o investidor: o BCM não força ninguém a trocar de método. O kernel transforma qualquer protocolo — incluindo OERA — em PEI, jogos, rotinas e relatórios. Isso é o que escala.

Quem paga, quem não paga e quanto.

A família nunca paga. O profissional libera o acesso. Adoção social, custo recorrente B2B.

PROFISSIONAL

R\$ 297 /mês

até 10 crianças

CLÍNICA

R\$ 997 /mês

até 30 crianças

ESCOLA

R\$ 1.997 /mês

pool de 50 crianças

B2G ENTERPRISE

Custom

por nº de crianças

T R A J E T Ó R I A C O N S E R V A D O R A A O B R E A K E V E N

Período	Etapa	Tração	MRR	Leitura
Mês 1-3	Piloto Gradual	0 pagantes	R\$ 0	validação clínica
Mês 4-6	Pós-milestone	15 pagantes	R\$ 10.000	1ª prova de receita
Mês 7-9	Expansão Fortaleza	50 pagantes	R\$ 35.000	ativa Tranche 2
Mês 10-12	Expansão regional	120 pagantes	R\$ 85.000	modelo claro
Ano 2 — Q1	Escala SaaS	250 pagantes	R\$ 175.000	mix completo
Ano 2	Breakeven	350+ pagantes	R\$ 245.000	sustentável

A P R O P O S T A

5% do BCM por R\$ 75.000.

Aporte em 3 tranches. Gatilhos objetivos. Risco protegido a cada etapa.

TRANCHE 1

Assinatura

R\$ 30K

Contrato assinado · acesso liberado · viagem inicial · onboarding

TRANCHE 2

Prova de mercado

R\$ 25K

Somente com 50 usuários pagantes ativos na plataforma

TRANCHE 3

Resultado

R\$ 20K

Publicação científica conjunta OU 100 usuários pagantes ativos

O QUE O GRADUAL RECEBE

- 5% de equity no BCM (LaVita Code)
- 6 meses gratuitos · clínica completa
- 30% de desconto permanente no Plano Clínica
- 25% de desconto em desenvolvimento de software
- Coautoria científica · OERA como protocolo nativo

O QUE PROTEGE O INVESTIDOR

- Tranche 2 não é por data — é por receita ativa
- Tranche 3 exige publicação OU escala
- Acesso gratuito exige mín. 10 crianças em 60 dias
- Relatórios trimestrais de uso, receita e roadmap
- Voto técnico-clínico em decisões de produto

O cheque se paga sozinho.

Antes do BCM crescer, antes de qualquer assinante, antes da Tranche 2 — só com o desconto em software, o investimento já paga a si mesmo.

CENÁRIO CONSERVADOR

Softhouse atual = R\$ 8.000 / mês

Custo mensal hoje **R\$ 8.000**

Desconto LaVita 25% **R\$ 2.000**

Economia anual **R\$ 24.000**

PAYBACK DO INVESTIMENTO

3,1 anos *só com economia em software*

CENÁRIO REALISTA • GRADUAL

Softhouse atual = R\$ 12.000 / mês

Custo mensal hoje **R\$ 12.000**

Desconto LaVita 25% **R\$ 3.000**

Economia anual **R\$ 36.000**

PAYBACK DO INVESTIMENTO

2,1 anos + *os 5% de equity ficam de bônus*

Tradução comercial: o equity de 5% deixa de ser "o retorno" e passa a ser "o bônus". O retorno já está no contrato de serviços.

Quatro camadas de retorno empilhadas.

Cada camada existe independente das outras. A composição é o que torna a proposta assimétrica.

OPERACIONAL • CERTO

01

Economia em desenvolvimento de software

25% de desconto enquanto o Gradual mantiver participação. Em 3 anos típicos, R\$72K-R\$108K em economia direta. Já paga o cheque.

R\$ 24K-36K /ano

OPERACIONAL • CERTO

02

Desconto permanente Plano Clínica + 6 meses grátis

Acesso completo da clínica por 6 meses (R\$ 5.982) + 30% off vitalício (R\$ 35.892 em 10 anos).

R\$ 41.874+

ESTRATÉGICO • ALTO VALOR

03

Posição estratégica • OERA nativo • coautoria científica

Primeiro catálogo protocolar parceiro • publicações conjuntas • taxonomia clínica do mercado.

Estratégico

EQUITY • UPSIDE

04

5% do BCM

Hoje: R\$ 75K • com 350 assinantes: R\$ 125-175K • com 1.000: R\$ 375-500K • com presença nacional: R\$ 1-2M.

10x - 25x

Camadas 1 e 2 sozinhas devolvem o cheque. Camadas 3 e 4 são puro upside.

Cada lado traz o que o outro leva anos para construir.

O QUE O GRUPO GRADUAL TRAZ

23 anos	de operação clínica ABA contínua
2.000+	crianças atendidas
100/ano	ATs formados pela equipe
HC-USP	parceria institucional ativa
Dra. Leila	autoridade científica e rede acadêmica
OERA	protocolo proprietário pronto para escalar

O QUE O BCM ENTREGA

3 anos	de construção • R\$150K investidos
12 módulos	em produção • não em roadmap
Kernel	que aceita qualquer protocolo clínico
35 min	para gerar PEI defensável completo
32 jogos	com telemetria clínica integrada
AWS • Claude	stack moderna • LGPD • escalável

Juntos, Gradual e BCM chegam onde nenhum dos dois chega sozinho — **uma referência clínica nacional sustentada por software auditável.**

QUEM CONSTRUÍU

Autoridade técnica + autoridade emocional.

Um time enxuto, com motivação real e produto já construído.

FUNDADOR • CTO

Rafael Dias

Engenheiro de Software

Autista. 10+ anos em Angular, NestJS e plataformas SaaS clínicas. Investiu R\$150 mil do próprio bolso para construir o BCM ao longo de 3 anos. O produto nasceu de vivência pessoal e foi sustentado por arquitetura SaaS sênior.

CO-FUNDADORA • HEAD DE PRODUTO

Laura Dias

Psicologia • Acompanhante Terapêutica

A origem clínica e humana do projeto. Pesquisadora em TEA e tecnologias assistivas. Garante que cada decisão de produto tenha lastro clínico real, e não apenas elegância de engenharia. Define a régua de aceitação dos módulos terapêuticos.

R\$ 150K

capital próprio investido

3 anos

de construção contínua

AWS

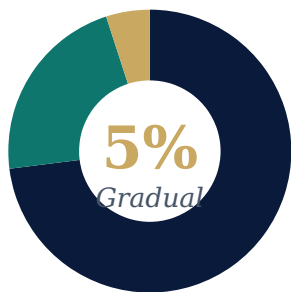
Activate aprovado

Claude

IA aplicada ao kernel

Voz real no produto, sem bloquear a operação.

CAP TABLE • BCM (LaVita Code)



FUNDADORES

■ **73% Rafael Dias** · CTO, produto e tecnologia

■ **22% Laura Dias** · cofundadora, lastro clínico

INVESTIDOR

■ **5% Grupo Gradual** · entrada via cheque de R\$ 75K

DIREITOS DO INVESTIDOR

- Relatório trimestral de uso, receita e roadmap
- Voto técnico-clínico em decisões de produto
- Coautoria em publicações científicas
- Pro-rata em rodada futura
- Priorização do catálogo Gradual no kernel

FRONTEIRAS — O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO

- Acesso ao código-fonte
- Veto em parcerias comerciais externas
- Obrigação de aporte adicional
- Interferência em execução técnica diária

PAPEL DA DRA. LEILA BAGAILOLO

- Validação dos protocolos embarcados
- Integração OERA + lista preferencial em até 6 meses
- Coautoria científica conjunta
- Abertura de rede acadêmica e institucional

Toda dúvida razoável já foi respondida na estrutura.

“E se o produto não vender?”

Tranche 2 só é paga com 50 usuários pagantes ativos. Sem venda, não há segundo aporte.

“E se a clínica não usar?”

Acesso gratuito exige mínimo de 10 crianças em 60 dias. Sem uso, não há validação real para ninguém.

“E se virar só mais um software?”

Diferencial é o kernel + OERA nativo + telemetria + relatórios defensáveis. Não é cadastro nem prontuário.

“E se 5% for participação pequena?”

5% agora é posição de investidor-âncora — antes da rodada, antes da escala. O valor está no timing, não no tamanho.

“E se houver conflito técnico?”

Gradual tem voto em decisões com impacto clínico. Rafael mantém a responsabilidade técnica e arquitetura.

“E se o equity demorar a maturar?”

Economia de softhouse + desconto Plano Clínica criam retorno operacional imediato, independente da escala.

A estrutura inteira foi desenhada para dizer uma coisa: **vocês pagam pela prova, não pela promessa.**

A decisão não é *se* investir. É *que posição* ocupar.

SE O GRADUAL ENTRA AGORA

- Vira primeiro investidor clínico do BCM
- Molda o produto antes da escala
- OERA passa a ser o primeiro protocolo nativo embarcado
- Garante coautoria, dados e participação
- Ocupa a narrativa científica do mercado
- **Captura economia operacional imediata**

SE O GRADUAL ESPERA

- Outro grupo clínico ocupa a posição
- Outro protocolo vira o primeiro nativo
- Entrada futura é como cliente, não como sócio
- Janela de validação inicial fecha
- Poder de moldar o produto diminui
- **Custo de softhouse atual continua cheio**

O custo da espera não é apenas perder o deal — é perder a posição.

Pronto para contrato.

Produto	Plataforma clínica ABA digital — funcional hoje
Investimento total	R\$ 75.000 em 3 tranches
Equity oferecido	5% do BCM (LaVita Code) · Rafael 73% / Laura 22% / Gradual 5%
Tranche 1 — Assinatura	R\$ 30.000 · contrato + onboarding + viagem inicial + início OERA
Tranche 2 — Mercado	R\$ 25.000 · apenas com 50 usuários pagantes ativos
Tranche 3 — Resultado	R\$ 20.000 · publicação conjunta OU 100 pagantes ativos
Acesso Gradual	6 meses gratuitos para toda a clínica · uso mínimo de 10 crianças
Desconto Plano Clínica	30% permanente enquanto o Gradual mantiver participação no BCM
Serviços LaVita Code	25% abaixo do mercado para desenvolvimento de software
Protocolos Gradual	OERA prioritário + lista preferencial como catálogo nativo
Governança	Voto técnico-clínico · relatórios trimestrais · coautoria
Validade	15 dias · até 22 de maio de 2026

Do contrato ao primeiro usuário em 30 dias.

SEMANA 1

Assinatura e onboarding

Contrato assinado · tranche 1 liberada · viagem Rafael + Laura para SP · alinhamento presencial

SEMANA 2

Integração inicial

Entrega dos jogos Gradual · mapeamento OERA · acessos da clínica · primeiros terapeutas preparados

MÊS 1

Primeiros usuários reais

Mínimo de 10 crianças cadastradas · primeiros dados clínicos · feedback direto · iteração rápida

MÊS 3

Gatilho da Tranche 2

Relatório de uso · expansão comercial inicial · tranche 2 dispara apenas com 50 pagantes ativos

MÊS 6

OERA nativo + escala

Catálogo OERA publicado · publicação conjunta ou 100 pagantes · tranche 3 · expansão nacional

Primeira meta concreta: o BCM rodando no Gradual em até 30 dias.

PRÓXIMOS PASSOS

Vocês têm 23 anos construindo o que o BCM precisa.

Eu tenho a plataforma que leva 3 anos para construir.

1 Assinar carta de intenção

2 Formalizar contrato com
assessoria

3 Liberar Tranche 1

4 Iniciar SP em 7 dias

Rafael Dias

Fundador · BCM (LaVita Code)

rafaeldias@lavitacode.com.br
+55 85 9 9444-8858
lavitacode.com.br